

**Université MENTOURI 3**  
**Faculté de médecine chalet des pins Constantine**  
**Module de gastroentérologie**  
**4 Emme année de médecine**



# **Cours pratique**

## **Conduite à tenir devant un ictère**

**Dr. MENOURA. R**  
**Maitre-assistant Hepato-biliopancreatique**  
**Service de chirurgie digestive et endocrinienne**  
**E.H. DIDOUCHE MOURAD**  
**CONSTANTINE 2025/2026**

## Objectifs d'apprentissage

- Savoir reconnaître un ictère, évaluer sa gravité et prioriser les actions.
- Conduire une démarche diagnostique **rapide, logique et rentable**.
- Différencier **ictère pré-hépatique, hépatique, post-hépatique**.
- Prescrire **les bons examens** (ordre, indications, interprétation).
- Initier **les premières mesures thérapeutiques** et savoir **quand référer/hospitaliser**.

## 1) Définitions et rappels essentiels

- **Ictère** = coloration **jaune** des téguments, muqueuses et conjonctives par **hyperbilirubinémie** (généralement visible  $> 30\text{--}40\text{ }\mu\text{mol/L}$ ).
- **Bilirubine non conjuguée (libre) vs conjuguée (directe)** :
  - *Non conjuguée* : hydrophobe, liée à l'albumine, **n'apparaît pas dans les urines**.
  - *Conjuguée* : hydrophile, **urines foncées** si élevée.
- **Prurit + urines foncées + selles décolorées** → **cholestase** probable.

**Axes physiopathologiques** : 1. **Production (hémolyse)** → ictère **pré-hépatique**. 2. **Captation/conjugaison/excrétion hépatocytaire** → ictère **hépatique**. 3. **Obstacle biliaire (VBI/VBE)** → ictère **post-hépatique (cholestatique)**.

## 2) Démarche initiale (triage et urgence)

**Toujours débuter par l'évaluation de la gravité** : - **Signes vitaux** : T°, FC, TA, SpO<sub>2</sub> . - **Signes de sepsis/angiocholite** : fièvre, frissons, douleurs de l'hypochondre droit/épigastre, confusion, hypotension (→ **pentade de Reynolds** = urgence vitale). - **Insuffisance hépatique aiguë** : astéraxis, confusion/encéphalopathie, **TP/INR altéré**, hypoglycémie, ictère rapidement

progressif. - **Cholestase gravidique sévère** ou ictère néonatal/infantile : **situations spécifiques** (référer rapidement).

**Conduites immédiates si gravité** : - Mise en condition : voie veineuse, remplissage si besoin, antalgiques, antiémétiques. - Prélèvements : **NFS, CRP, bilan hépatique complet, hémocultures** si fièvre. - Antibiothérapie probabiliste si **angiocholite suspectée** (adapter au contexte local et à l'écologie). - Appeler **chirurgie digestive/GE** pour **drainage biliaire** en urgence si choc/sepsis persistant.

### 3) Interrogatoire orienté (check-list)

- **Début & évolution** : brutal (lithiase) vs progressif (tumeur, cholangite sclérosante).
- **Douleurs** : colique hépatique ? irradiation dorsale (pancréas) ?
- **Fièvre/frissons** : infection biliaire.
- **Prurit, urines foncées, selles décolorées** : cholestase.
- **Expositions** : alcool, drogues IV, rapports sexuels non protégés, voyages, eau/aliments à risque (hépatites A/E).
- **Médicaments & toxiques** (hépatotoxicité) : paracétamol (surdosage), anti-TB, amoxicilline-ac.clav., statines, antipsychotiques, antibiotiques macrolides, antifongiques, plantes.
- **ATCD** : hépatites virales, cirrhose, lithiase, chirurgie biliaire, maladies auto-immunes (CBP, HAI), maladies hématologiques (hémolyse).
- **Terrain** : âge, grossesse, IMC, diabète, immunodépression.
- **Contexte familial** : Gilbert, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson, Rotor.

### 4) Examen clinique (ce qu'il faut chercher)

- **Coloration** : conjonctives (précoce), peau; gratter → lésions de grattage.
- **Douleur** : Murphy +/-, défense HCD, masse épigastrique (tête pancréas).
- **Foie/Rate** : hépatomégalie, splénomégalie (hypersplénisme/hémolyse/HTP).

- **Signes de cirrhose** : angiomes stellaires, érythème palmaire, ascite, circulation collatérale.
- **Encéphalopathie** : astérisis, confusion.
- **Sepsis** : ictère + fièvre + douleur = **triade de Charcot** (penser angiocholite).

## 5) Examens complémentaires – quoi prescrire, dans quel ordre

### A. Biologie (1re intention pour tous)

- 1) **Bilirubine totale et fractionnée** (directe/indirecte).
- 2) **Transaminases (ASAT/ALAT), PAL, γGT.**
- 3) **NFS** (anémie, hémolyse), **réticulocytes**, **LDH**, **haptoglobine**, **frottis** si hémolyse suspectée.
- 4) **TP/INR, albumine, glucose** (fonction hépatique/synthèse).
- 5) **Ions, créatinine** (co-morbidités, préparation aux examens/contrastés).
- 6) **Sérologies** selon contexte : HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM, HCV Ac ± ARN, HEV IgM (grossesse), VIH.
- 7) **Auto-immun** (si cytolyse/cholestase inexpliquées) : ANA, ASMA, LKM, AMA, IgG/IgM.
- 8) **Dosages ciblés** : ferritine, transferrine, céruloplasmine (<40 ans), alpha-1 antitrypsine, bilan thyroïde.

**Lecture rapide des patterns** : - **Hémolyse** : bilirubine indirecte ↑, **LDH** ↑, haptoglobine ↓, **réticulocytes** ↑, **urines claires**. - **Hépatocellulaire** : **ALAT/ASAT » PAL/γGT**, bilirubine mixte. - **Cholestatique** : **PAL/γGT » ALAT/ASAT**, bilirubine directe ↑, **urines foncées, selles pâles**.

## B. Imagerie

- 1) **Échographie abdominale (examen de 1re intention) :**
  - Dilatation des **voies biliaires intra/extra-hépatiques** ?
  - Présence de **calculs, boues, masse** hépatique/pancréatique/vésiculaire ?
  - **Vésicule** : distension, parois, sludge, calculs, signe de Murphy échographique.
- 2) **Si voies dilatées ou suspicion d'obstacle :**
  - **TDM abdominale** (pancréas, VBP) ± **IRM/CP-IRM** pour cartographier l'obstacle.
- 3) **Si geste thérapeutique attendu :**
  - **CPRE** (extraction calculs, sphinctérotomie, stent) – à discuter avec GE.
- 4) **Si CPRE impossible/échec :**
  - **Drainage biliaire percutané** (radiologie interventionnelle).

## 6) Arbre décisionnel pratique

1. **Ictère confirmé** (clinique + BT > 30–40  $\mu\text{mol/L}$ ).
2. **Gravité ?** (sepsis, choc, confusion, TP/INR $\uparrow$ ) → **hospitaliser/urgence**.
3. **Pattern biologique :**
  - Indirecte prédominante → **rechercher hémolyse**.
  - PAL/ $\gamma$ GT très  $\uparrow$ , urines foncées, selles pâles → **cholestase**.
  - ALAT/ASAT très  $\uparrow$  → **hépatique** (hépatite aiguë, toxique).
4. **Échographie** : voies **dilatées = obstacle** → TDM/IRM → **CPRE/Drainage**.
5. **Voies non dilatées = cause hépatique** (hépatite, CBP/PSC, DILI, infiltration) → bilans ciblés, hépatologie.

## 7) Prises en charge par étiologie (principes)

### A. Ictère pré-hépatique (hémolytique)

- Identifier la cause : hémolyse auto-immune (test de Coombs), paludisme, drépanocytose, déficit G6PD, microangiopathies, prothèses valvulaires, toxiques.
- Conduites :
  - Traitement **étiologique** (antipaludique, arrêt toxique, corticothérapie si AHAI, transfusion si besoin, folates).
  - Surveillance **hémodynamique**, diurèse, bilan fer.

### B. Ictère hépatocellulaire

- Causes : **hépatites virales**, **toxicité médicamenteuse (DILI)**, alcool, ischémie, auto-immunes, métaboliques (Wilson, hémochromatose), infiltration tumorale.
- Conduites :
  - Arrêt **immédiat** des toxiques/médicaments suspects.
  - Hépatite virale aiguë : traitement de support ± antiviral selon type/gravité.
  - Suspicion **insuffisance hépatique aiguë** (TP/INR altéré, encéphalopathie) → **référer en centre spécialisé** (évaluation transplantation).

### C. Ictère cholestatique post-hépatique (obstructif)

- Causes fréquentes : **lithiase de VBP**, tumeur tête pancréas/ampoule de Vater/CHC cholangiocarcinome, sténoses (post-CPRE, PSC), parasitoses (selon régions).
- Conduites :
  - **Angiocholite** (sepsis) : antibiothérapie IV probabiliste, réanimation si besoin, **drainage biliaire urgent** (CPRE en 1er si accessible).
  - Lithiase non compliquée : extraction endoscopique, cholécystectomie secondaire.
  - Masse tumorale : bili-MRI/TDM de staging, **drainage** si ictère cholestatique symptomatique/prurit/infection ou avant chirurgie/chimio (discussion RCP).

## 8) Focus Angiocholite (urgence)

- **Diagnostic clinique** : triade de Charcot = **douleur HCD + fièvre + ictère**. Gravité si **hypotension/confusion** (pentade de Reynolds).
- **Biologie** : cholestase, cytolyse variable, leucocytose/CRP, hémocultures.
- **Imagerie** : écho initiale; TDM/IRM si doute; CPRE thérapeutique.
- **Prise en charge** :
  - Réanimation : VVP, remplissage, antalgie, monitoring, hémocultures.
  - **Antibiothérapie IV** couvrant entérobactéries + anaérobies (adapter aux protocoles locaux, terrain, ATB récents, résistance locale).
  - **Drainage biliaire** (CPRE en priorité) dès que possible si sepsis persistant/obstacle.

## 9) Situations particulières

- **Grossesse** : penser **cholestase intrahépatique gravidique**, HEV, prééclampsie/HELLP, lithiase; bilan et imagerie **non irradiants** (écho/IRM sans gadolinium si besoin). Collaboration obstétrique.
- **Sujet âgé** : étiologies néoplasiques/lithiasiques ++ ; attention aux **médicaments** et **fonction rénale**.
- **Pédiatrie** : ictère néonatal/prolongé → causes spécifiques (atrésie biliaire, infections, métaboliques) → référer pédiatrie spécialisée.
- **Immunodéprimé** : infections opportunistes, médicaments; bilan élargi.

## 10) Ordonnances/examens types (modèles)

### A. Bilan de base (ambulatoire non grave)

- NFS, plaquettes, **BT/BD/BI, ASAT/ALAT, PAL/γGT, TP/INR, albumine, créatinine/Na/K**.
- Échographie hépatobiliaire **en priorité**.
- Selon contexte : sérologies virales (A/B/C/E), auto-immun (ANA, ASMA, AMA), ferritine, transferrine, céruloplasmine (<40 ans), TSH.

## B. Suspicion d'angiocholite (urgences)

- Hémocultures x2, NFS, CRP, lactate, bilan hépatique complet, coagulation, gaz du sang.
- Antalgiques IV, antibiothérapie probabiliste, évaluation CPRE urgente.

## 11) Erreurs fréquentes à éviter

- Retarder l'**échographie** en première intention.
- Prescrire des **ATB** sans hémocultures si fièvre.
- **Oublier l'INR/TP** et l'évaluation de la **gravité** (encéphalopathie, hypoglycémie).
- Interpréter une **bilirubine isolée** sans fractionnement (directe/indirecte).
- Négliger l'**iatrogénie** médicamenteuse.

## 12) Messages clés (take-home)

- **Biologie + échographie** = duo incontournable.
- Devant **douleur + fièvre + ictère** → **angiocholite** jusqu'à preuve du contraire.
- **Voies biliaires dilatées** = obstacle → **imagerie avancée + drainage**.
- **Voies non dilatées** = cause hépatique → bilans ciblés, hépatologie.
- Adapter la prise en charge au **terrain** (grossesse, âge, comorbidités).

DR. raouf MENOURA